

■ 介護報酬改定／退院支援

退院当日の訪問リハ、 介護保険での算定を要望

全国リハ医療協議会が17項目 回復期退院患者の約3分の2はリハ未導入

厚生労働省は9月16日、令和9年度介護報酬改定に向けて医療系サービスの関係団体からヒアリングを行った。日本リハビリテーション医学会やPT・OT・STの3協会など9団体でつくる全国リハビリテーション医療関連団体協議会は、通所・訪問リハの基本報酬の引き上げ、退院・退所当日の訪問リハ、移動・送迎への

評価など計17項目を要望した。今は退院日に医療機関側でリハの費用を算定できるため、介護保険の訪問リハ費は算定できない。訪問看護は主治医が必要と認めれば退院当日に訪問できる。協議会は同様に、主治医が必要と認めた場合にリハ専門職が当日訪問し、退院時共同指導の内容を自宅の環

境へすぐ反映できるよう求めた。提出資料では、回復期リハ病棟の退院患者の約3分の2にリハビリテーションサービスが導入されていなかったとの調査結果も示された。協議会は、受け手のケアマネジャー側の評価が連動していないとも指摘した。あくまで団体の要望で、今後の



退院の日から、自宅の環境に合わせた支援をつなぐ

分科会で議論される。

出典 [PT-OT-ST.NET](#) ↗

数字で見る

17項目

協議会の要望

9団体

リハ医療関連の構成団体

約2/3

回復期退院後にリハ未導入

■ 心臓リハ／高齢者評価

高齢者の心リハ、6分間歩行と最も関連したのは内在的能力

イタリアのMaugeri研究所の単施設コホート。心不全増悪、冠症候群、弁膜症、心臓手術後の551人(年齢中央値72歳、男性69%)。ICは認知・心理・移動・活力の4領域で、活力を握力で測る版と簡易栄養状態評価で測る版を使った。

年齢・性別・診断で調整すると、終了時の6分間歩行(予測値比)との関連はICが最も強く($\beta=0.571$ 、調整 $R^2=$



0.362)、FIは弱かった($\beta=-0.281$ 、 $R^2=0.235$)。歩行距離ではIC1あたり約61m。観察研究で、IC評価に基づく介入の効果は未検証だ。

出典 [J Nutr Health Aging](#) ↗

■ 医療AI／養成教育

米PT養成課程、学生の79%が生成AIを利用

回答した1,067人のうち79.9%が生成AIを使い、学生78.7%、教員85.6%だった。ツールはChatGPTが最多。学生は練習問題の作成(70.2%)や模擬の患者症例づくり(53.9%)、教員は症例づくり(61.5%)に使っていた。ためらう理由は信頼性や科学的な厳密さへの懸念と、提供企業への不信。自己申告の調査で回



答者の偏りもあり得る。筆者らは課程ごとの教育のばらつきを指摘し、適切な使い方を教える必要があるとする。

出典 [Physical Therapy](#) ↗

短 信

〈回復期リハ〉**骨格筋量の推定式、変化の追跡には弱い**

脳卒中554人・大腿骨骨折296人。入院時は一致したが、入退院間の変化の相関は0.20～0.23にとどまった

出典 [Arch Gerontol Geriatr](#) ↗

〈嚥下〉**院内発症の誤嚥性肺炎、費用は市中の2倍超**

スペインの943人。発生は100入院あたり3.04、死亡39.3%。嚥下スクリーニングは十分に使われていなかった

出典 [J Clin Nurs](#) ↗

〈転倒予防〉**オレキシン受容体拮抗薬、転倒は増えず**

19研究・約18万人のメタ解析。転倒OR0.76、骨折OR1.05。高齢者のデータが少なく慎重な解釈が要る

出典 [J Am Geriatr Soc](#) ↗

〈服薬〉**高齢者の処方カスケード、優先24種を特定**

カナダの229万人。鉄剤→下剤が11.9%、スタチン→鎮痛薬10.9%など、65種のうち24種を優先対象とした 出典 [BMJ](#) ↗

〈認知症〉**うつ既往の高齢者、SSRI継続で進行緩やか**

米NACCの688人。継続群は認知症の重症度の進行が緩やかで、剖検のラクナ・梗塞も少なかった(観察研究)

出典 [Am J Geriatr Psychiatry](#) ↗

〈嚥下〉**パーキンソン病の呼吸筋訓練で喉頭挙上が増加**

20人の前後比較。高解像度嚥下造影内圧検査で、訓練後に喉頭の挙上と移動量が増えた。対照群はない 出典 [Clinics](#) ↗

〈高齢者支援〉**高齢者虐待、動機づけ面接で心理的攻撃が減少**

香港の198人のRCT。支援者による4回の面接で、3か月後の軽度の心理的攻撃が減った($d=0.92$) 出典 [J Am Geriatr Soc](#) ↗

〈小児リハ〉**脳性麻痺の免荷トレッドミル、立位・歩行項目改善**

17のRCTのメタ解析。GMFMの立位・歩行領域は改善したが、歩行速度や持久力は差がなく確実性は低い

出典 [Disabil Rehabil](#) ↗